

AI NATIVE DOCTOR COPILOT

ContinuCare Copilot

面向医院的连续健康记忆与多智能体协作系统

让患者离院后的真实变化，在复诊前成为医生可信任的上下文



合成数据原型 · 不生成诊断、治疗或用药建议 · 医生保留最终决策权

医生真正缺的不是更多医学知识，而是连续健康记忆

患者离院后的几十天，仍然是医院信息系统最薄弱的一段。

患者真正生活的时间



今天的断点

医院只看到两端，过程成为空白

人工电话、微信群、患者回忆难以形成连续上下文

医生复诊时仍要重新拼接发生过什么

核心洞察

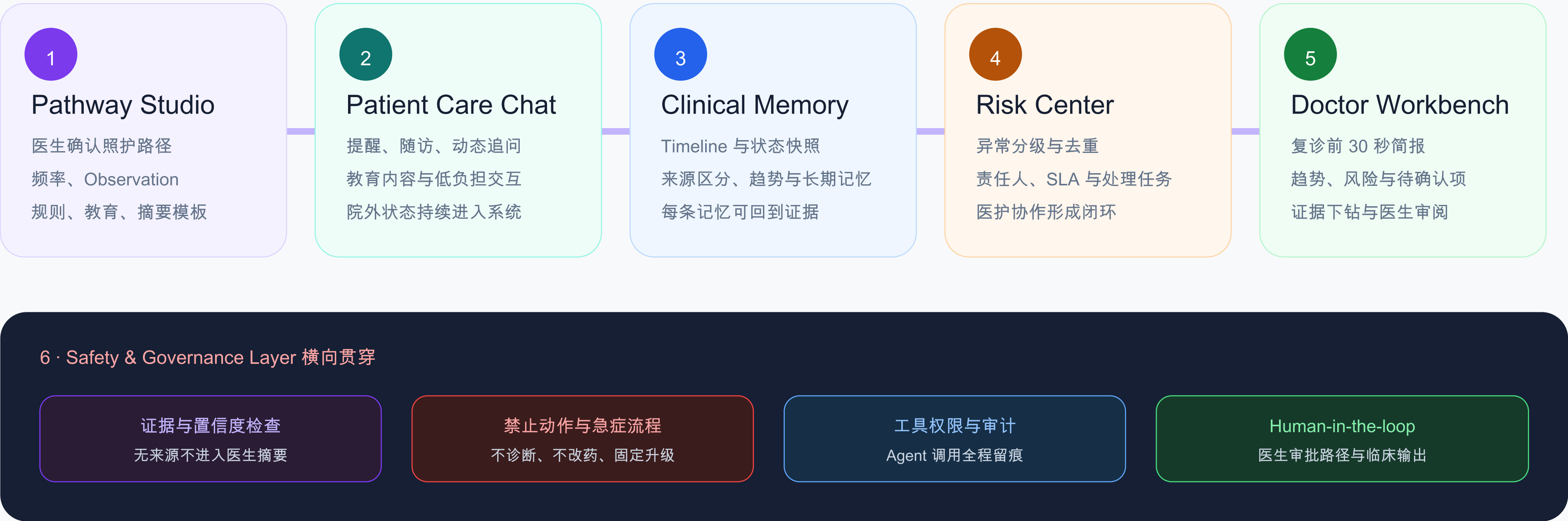
医生缺的是连续健康记忆

AI持续收集、理解、连接和重建院外时间

复诊前交付带证据的“上下文恢复”，而非诊断结论

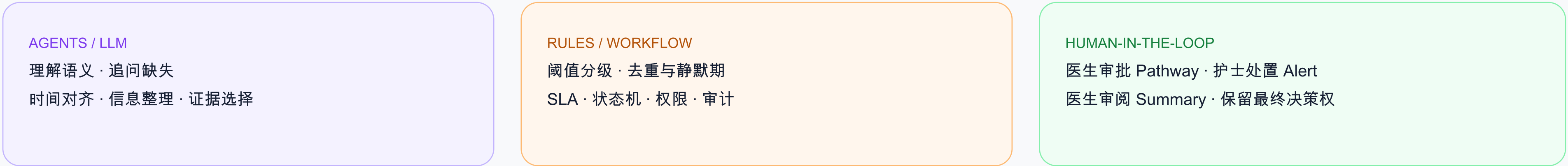
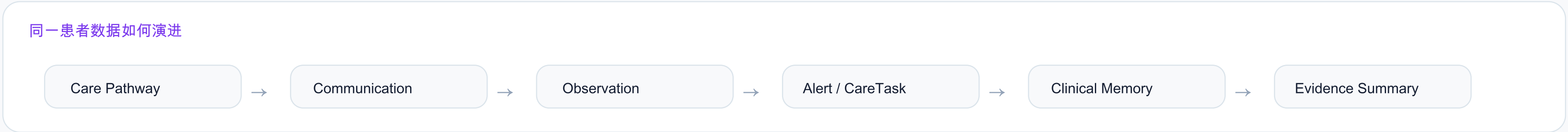
一套由 Care Pathway 驱动的 AI 连续照护操作系统

从路径设计到患者随访、风险闭环和医生复诊准备，形成完整产品栈。



一条从离院到复诊的完整 AI 连续照护闭环

六个 Agent 分工理解与整理；规则负责阈值与状态；医护保留关键审批和最终决策。



关键临床等级、急症提示与最终决策不交给模型

六个专职 Agent 围绕同一 Clinical Memory 协作

每个 Agent 只完成明确任务，Orchestrator 管理上下文、工具、Schema 与审计。



每次 Agent 输出：结构化字段 · evidence_refs · 置信度 · 模型/Prompt 版本 · requires_human_review

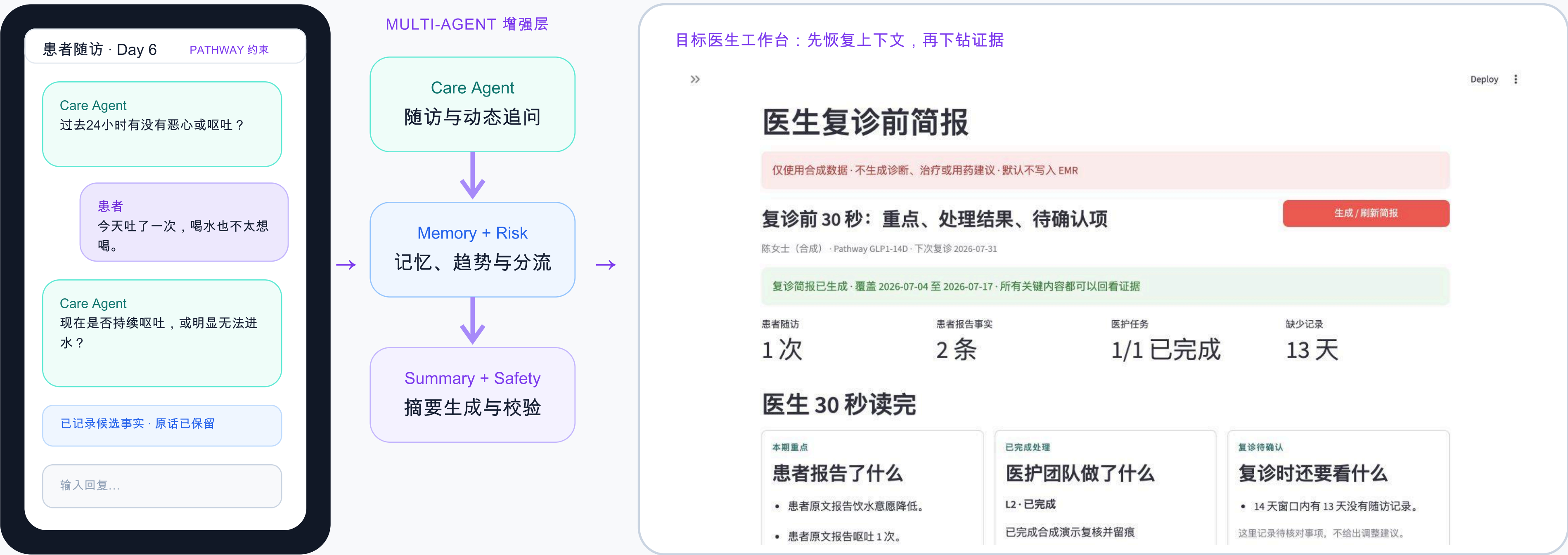
一次院外随访，不是一次模型调用，而是一条受控 workflow

AI 理解语言，规则决定阈值，医护完成审批与处置。



原型展示未来产品形态：患者端低负担，医生端高密度

左侧是当前可点击原型；中间是入围后接入的 Agent 协作层；右侧是目标医生工作台。



原型是目标产品形态；入围后接入 Aily Multi-Agent，补齐自适应、长期记忆与证据摘要

亮点不是“用了大模型”，而是把 Agent 变成可治理的临床执行器

临床记忆、Agent 编排、混合智能和证据图共同构成可落地壁垒。

01 · Clinical Memory

把单次对话变成患者长期状态

Timeline、状态快照、来源区分、医生关注点与反馈

02 · Agent Orchestration

专职任务、工具控制与失败降级

结构化 I/O、最小权限、模型版本、Prompt 版本、Audit ID

03 · Hybrid Intelligence

LLM 理解语言，规则决定阈值

关键分级、急症提示与临床确认不交给模型

04 · Evidence Graph

摘要结论可回到事实、规则和动作

医生不是“相信模型”，而是快速审阅被组织好的证据



Aily 承载 Agent 编排，飞书承载医护协作与运营闭环

外部平台通过适配器接入同一业务 Schema，不重写 Pathway、Memory 与安全边界。



真实状态：当前为平台无关原型；入围后接入 Aily/飞书并按同一 Schema 复用业务闭环

先用一个 Pathway 打穿闭环，再扩展为医院连续照护平台

原型证明产品形态与业务闭环；下一阶段把 Multi-Agent、平台协作和临床验证逐层接上。



让 AI 成为医生的连续记忆系统 而不是另一个聊天窗口

从单 Agent 到 Multi-Agent

多个专职 Agent 协作

Pathway 驱动任务与工具权限

Safety Agent 横向把关

从单次对话到 Clinical Memory

重建患者院外时间

Timeline、趋势、缺失与患者问题

复诊前恢复完整上下文

从黑盒生成到 Evidence Trace

每条结论都能被证明

原话、Observation、规则和任务

医生保留最终临床决策权

最终目标

把患者离院后的每一次变化，转化为医生复诊前可信任、可审阅、可行动的上下文